

2025 年 06 月 15 日

AD 诊疗有望迎来重磅进展，建议关注通化金马、东诚药业等

——医药行业周报（25/6/9-25/6/13）

投资评级：看好（维持）

证券分析师

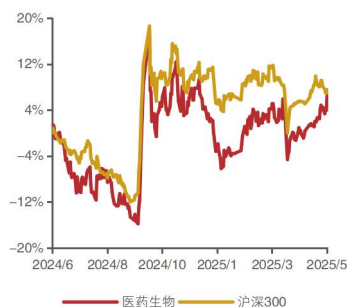
刘闯

SAC: S1350524030002

liuchuang@huayuanstock.com

联系人

板块表现：



投资要点：

- **本周医药市场表现分析：**6月9日至6月13日，医药指数上涨1.40%，相对沪深300指数超额收益为1.66%。本周，石药集团公告与阿斯利康达成战略研发合作协议，总金额高达53.3亿美元；中国生物制药预告近期将有标志性重磅对外授权交易，继续看好中国创新药出海潜力。建议关注：1）创新药作为较为确定的产业趋势，继续重点推荐A股热景生物、华纳药厂、信立泰、一品红、科兴制药、泽璟制药、科伦药业、恒瑞医药；港股三生制药、科伦博泰、康方生物、中国生物制药、信达生物、翰森制药；2）25年业绩逐季度边际改善、估值水平较低且有边际改善的个股，建议关注长春高新（创新药）、昆药集团、马应龙、开立医疗、迈瑞医疗、鱼跃医疗、海泰新光、麦澜德等。
- **医药指数和各细分领域表现、涨跌幅：**本周上涨个股数量218家，下跌个股263家，涨幅居前为易明医药（+38.49%）、赛升药业（+36.35%）、澳洋健康（+35.01%）、昂利康（+34.30%）、康惠制药（+30.93%），跌幅居前为人民同泰（-16.67%）、康乐卫士（-12.33%）、万邦德（-12.17%）、万泰生物（-10.20%）、ST中珠（-9.34%）。
- **阿尔兹海默症为全球尚未完全攻克疾病，创新口服化药琥珀八氢氨吡啶上市申请已获受理、市场潜力值得期待，建议关注通化金马。**根据GBD数据，2019年中国阿尔兹海默症（AD）及相关痴呆总人数为1314万，且随着老龄化人数有增加趋势，但在AD治疗领域，国内上市创新药相对较少。琥珀八氢氨吡啶是通化金马自主研发的1类新药，为胆碱酯酶抑制剂，同时抑制乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶，提升脑内乙酰胆碱水平，用于治疗轻中度AD，根据其III期试验，治疗26周后，实验组、安慰剂组和阳性药组ADAS-Cog评分较基线变化值分别为 3.98 ± 5.82 分、 0.84 ± 7.03 分、 3.18 ± 5.26 分，三组间差异具有统计学意义，试验组疗效好于阳性对照，且评分显著改善（ ≥ 3 分）的患者比例实验组（63.7%）也高于阳性药组（54.4%）和安慰剂组（40.0%）。安全性方面，琥珀八氢氨吡啶片12mg/d治疗26周不良事件发生率与安慰剂组及阳性药组相比无统计学差异（ $P > 0.05$ ）。2024年8月，琥珀八氢氨吡啶上市申请获得国家药监局受理，考虑到中国AD领域治疗市场广阔、且创新药物较少，建议关注通化金马。在AD检测方面，PET分子影像目前为金标准，尤其对早期无症状阶段识别具有不可替代性。东诚药业作为国内PET显影剂领域核心标的，用于诊断阿尔兹海默症的核素药物APN-1607目前已与CDE进行NDA前的沟通交流。
- **投资观点及建议关注标的：**展望2025年，我们认为医药板块已经具备多方面的积极发展因素，基本完成了新旧增长动能转换（创新替代仿制，出海能力提升），具体来看，1）国内创新产业已具规模，一批药企的创新布局迎来收获，恒瑞医药、翰森制药、科伦药业等传统pharma已完成创新的华丽转身；2）出海能力持续提升，创新药械的license out频频出现，中国企业已成为全球MNC非常重视的创新转换来源，重磅交易如科伦博泰、康方生物、百利天恒等。医疗设备、供应链等已在全球范围内占据较高的地位，在欧美发达市场以及新兴市场持续崭露头角，如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造等；3）老龄化持续加速，心脑血管、内分泌、骨科等慢性疾病需求持续提升，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI浪潮下，医药有望释放新的成长逻辑，短期信心有望显著提升。具体配置方面，建议关注创新药械（业绩/创新拐点的Pharma以及临床阶段的高价值资产）、出海（CXO及科研上游、供应链、医疗器械及高端生物药和制剂）、国产替代（医疗设备和高值耗材）、老龄化及院外消费（家用器械、中药等）、高壁垒行业（血制品、麻药），同时建议积极关注估值较低有望修复的优质标的。
- **本周建议关注组合：**信立泰、华纳药厂、热景生物、三生制药、昆药集团；
- **六月建议关注组合：**信立泰、科伦药业、中国生物制药、华纳药厂、科兴制药、热景生物、昆药集团、马应龙、开立医疗。

- **风险提示：**行业竞争加剧风险，政策变化风险，行业需求不及预期风险。

内容目录

1. 中国 AD 诊疗领域有望迎来重磅品种，建议关注通化金马、东诚药业等	5
2. 行业观点：坚持创新+出海+老龄化主线，关注国内政策修复	8
3. 风险提示	14

图表目录

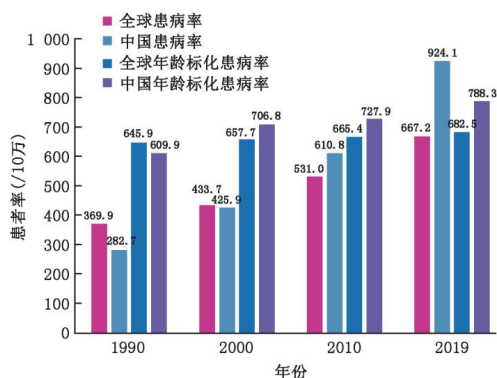
图表 1： 1990—2019 年全球、中国阿尔茨海默病及相关痴呆的患病率	5
图表 2： 2019 年全球和中国不同年龄段阿尔茨海默病及相关痴呆患病率（单位：每 10 万人）	5
图表 3： AD 致病机制假说图	6
图表 4： 全球主要治疗 AD 药物上市时间一览	6
图表 5： 主要治疗 AD 药物情况	7
图表 6： 阿尔茨海默病检测方法	8
图表 7： 本周申万医药行业涨幅 Top10	8
图表 8： 本周申万医药行业跌幅 Top10	9
图表 9： 2024 年初至今医药指数表现	9
图表 10： 申万各板块年初至今涨跌幅情况	10
图表 11： 年初至今医药子板块涨跌幅情况	10
图表 12： 本周医药子板块表现情况	10
图表 13： 申万各板块 PE 估值情况（截至 2025 年 6 月 13 日，整体 TTM 法）	11
图表 14： 申万医药及沪深 300 PE 估值情况（截至 2025 年 6 月 13 日，整体 TTM 法）	11
图表 15： 申万医药各细分板块 PE 估值情况（截至 2025 年 6 月 13 日，整体 TTM 法）	12
图表 16： 2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例（万亿）	12

1. 中国 AD 诊疗领域有望迎来重磅品种，建议关注通化金马、东诚药业等

阿尔茨海默症（AD）是一种不可逆神经退行性疾病，临床表现以获得性认知功能损害为核心症状，涉及记忆、学习、定向、理解、判断、计算、语言和视空间等认知域，不同程度地影响日常生活能力及社会职业功能。AD 及其他认知障碍性疾病患者的基本生活自理能力下降，不仅严重影响患者的生命健康，还需要长期照料服务，给家庭和社会带来了沉重的经济和照料负担。

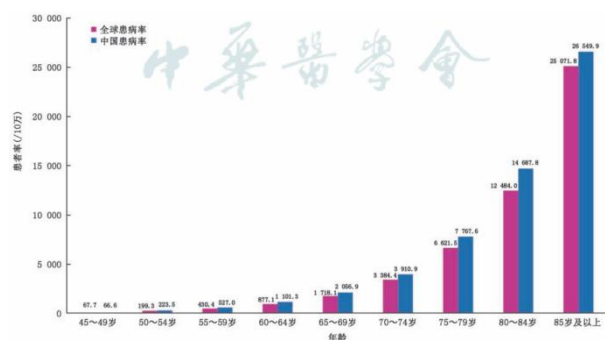
根据全球疾病负担研究（GBD）数据，2019 年全球 AD 及相关痴呆的患病人数达到 5162 万，总体患病率为 667.2/10 万，年龄标化患病率为 682.5/10 万；同年，中国 AD 及相关痴呆总人数为 1314 万。

图表 1：1990—2019 年全球、中国阿尔茨海默病及相关痴呆的患病率



资料来源：中国阿尔茨海默病蓝皮书，华源证券研究所

图表 2：2019 年全球和中国不同年龄段阿尔茨海默病及相关痴呆患病率（单位：每 10 万人）



资料来源：中国阿尔茨海默病蓝皮书，华源证券研究所

AD 发病机制极为复杂，目前尚未完全明确，主流发病机制假说包括 β -淀粉样蛋白（ $A\beta$ ）级联假说、tau-蛋白过度磷酸化假说、神经炎症假说、胆碱能神经异常学说等。

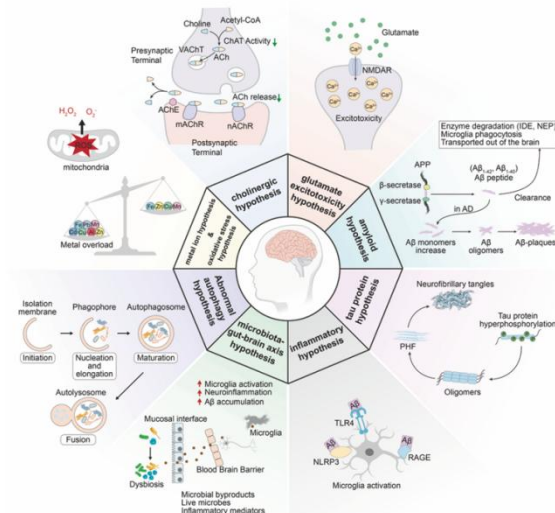
1) $A\beta$ 级联假说：正常情况下， $A\beta$ 以单体形式存在，具有一定的生理功能，然而在 AD 患者大脑中， $A\beta$ 会异常聚集形成寡聚体和纤维状沉淀，这些沉淀会破坏神经元之间的突触连接，引发神经毒性，导致神经元死亡，进而出现认知功能障碍。

2) Tau 蛋白过度磷酸化假说：tau 蛋白是一种微管相关蛋白，主要功能是维持微管的稳定性，在 AD 患者大脑中，tau 蛋白发生过度磷酸化，导致其与微管结合能力下降，微管解聚，从而破坏神经元的轴突运输，最终导致神经元功能障碍和死亡。

3) 神经炎症假说：AD 患者大脑中存在慢性炎症反应， $A\beta$ 聚集和 tau 蛋白异常会激活小胶质细胞和星形胶质细胞，释放多种炎症因子，如白细胞介素-1 β （IL-1 β ）、肿瘤坏死因子- α （TNF- α ）等，这些炎症因子进一步损伤神经元，加重 AD 病理进程。

4) 胆碱能神经异常假说: 胆碱能神经系统与认知的发生密切相关, 在老年人及痴呆患者中均可发现胆碱能神经元丢失、乙酰胆碱水平下降和乙酰胆碱受体功能障碍等表现, 海马、前额叶、杏仁核和基底节等与觉醒、注意力、学习和记忆等相关脑区的胆碱能神经元进行性丢失导致乙酰胆碱的存储和释放减少, 从而引起记忆和其他认知功能障碍。

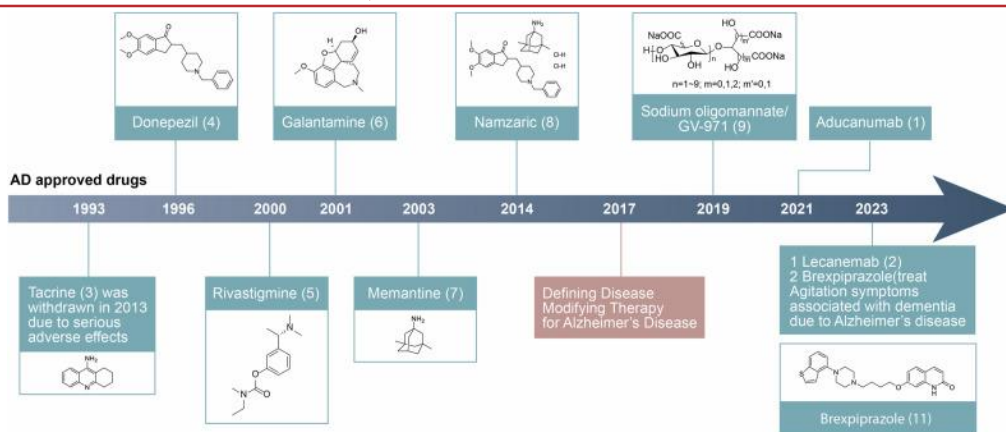
图表 3: AD 致病机制假说图



资料来源: 《Recent advances in Alzheimer's disease: mechanisms, clinical trials and new drug development strategies》作者 Jifa Zhang et al., 华源证券研究所

目前阿尔茨海默病 (AD) 治疗包括疾病修饰治疗 (DMT) 和对症疗法, DMT 类药物如仑卡奈单抗通过清除大脑中的 β 淀粉样蛋白沉积发挥作用, 对症治疗方面, 常用的胆碱酯酶抑制剂 (多奈哌齐、重酒石酸卡巴拉汀、加兰他敏) 能增强胆碱能神经传导, 美金刚可调节谷氨酸能神经传递, 可改善语义记忆。

图表 4: 全球主要治疗 AD 药物上市时间一览



资料来源: 《Recent advances in Alzheimer's disease: mechanisms, clinical trials and new drug development strategies》作者 Jifa Zhang et al., 华源证券研究所

中国市场方面, 获批阿尔茨海默病治疗药物主要包括胆碱酯酶抑制剂 (多奈哌齐、卡巴拉汀、加兰他敏)、NMDA 受体拮抗剂美金刚以及肠道菌群调节剂甘露特钠等。仑卡奈单抗 (卫材公司) 和多奈单抗 (礼来公司) 分别于 2024 年获批上市, 但根据说明书, 仑卡奈单抗

和多奈单抗在开始治疗之前，均需要确认存在 β 淀粉样蛋白病理（通过 β 淀粉样蛋白正电子发射断层显像（PET）确认）。

图表 5：主要治疗 AD 药物情况

治疗类别	治疗方法	机制	推荐药物	疗效评估
DMT（疾病修饰治疗）	靶向 A β 单克隆抗体	清除 A β 沉积，减少神经损伤，延缓 tau 病理进展	仑卡奈单抗（Leqembi®）	- 脑淀粉样斑块负担显著降低（PET） - CDR-SB 衰退减缓 27%（三期临床试验） - 延缓病程 2-3 年（三期临床试验）
	靶向 tau 蛋白疗法	靶向 A β 斑块中的 N3pG 抑制 tau 蛋白表达或清除	多奈单抗（Donanemab） E2814、BIB080（反义寡核苷酸）	- CDR-SB 衰退减缓 29%（三期临床试验） - 综合 AD 评分衰退延缓 22%（三期临床试验） - 降低脑脊液 tau 水平（临床前数据）
	胆碱酯酶抑制剂	增强胆碱能神经传导	多奈哌齐（乙酰）；重酒石酸卡巴拉汀（乙/丁酰）；加兰他敏（乙酰）	- 改善步态，降低跌倒风险 - 降低海马萎缩率（45%） - 延缓基底前脑萎缩
对症治疗	NMDA 受体拮抗剂	调节谷氨酸能神经传递	美金刚	- 可能改善语义记忆
	肠道菌群调节剂	调节菌群平衡，减轻神经炎症，减 A β /tau 病理	甘露特钠（GV-971）	- 改善认知功能 - 降低外周血苯丙氨酸/异亮氨酸
	植物提取物	抗氧化/抗炎	银杏叶提取物 EGb761	- 可能改善认知及精神症状

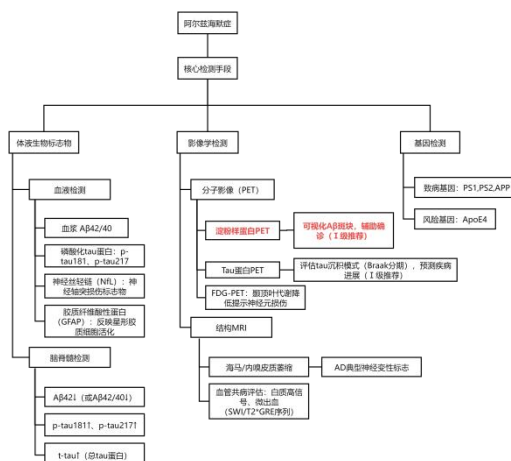
资料来源：《中国阿尔茨海默病蓝皮书》，华源证券研究所

琥珀八氢氨吡啶是通化金马自主研发化学 1 类新药，拥有完全自主知识产权，是一种新型强效、机制明确的胆碱酯酶抑制剂，能同时抑制乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶，提升脑内乙酰胆碱水平，用于治疗轻中度阿尔茨海默病（AD）。

琥珀八氢氨吡啶 III 期试验证实了药物疗效，治疗 26 周后，实验组、安慰剂组和阳性药组 ADAS-Cog 评分较基线变化值分别为 3.98 ± 5.82 分、 0.84 ± 7.03 分、 3.18 ± 5.26 分，三组间差异具有统计学意义，试验组疗效好于阳性对照，且评分显著改善（ ≥ 3 分）的患者比例实验组（63.7%）也高于阳性药组（54.4%）和安慰剂组（40.0%）。安全性方面，琥珀八氢氨吡啶片 12mg/d 治疗 26 周的不良事件发生率与安慰剂组及阳性药组相比无统计学差异（ $P > 0.05$ ）。2024 年 8 月，琥珀八氢氨吡啶上市申请获得国家药监局受理。

在检测方面，阿尔茨海默病（AD）的诊断依赖多维度评估，但传统认知量表和脑脊液检测存在局限性，PET 分子影像技术通过直观显示脑内 β 淀粉样蛋白和 Tau 蛋白沉积，成为确诊 AD 金标准，尤其对早期无症状阶段识别具有不可替代性。东诚药业是国内 PET 显影剂领域的核心标的，用于诊断阿尔兹海默症的核素药物 APN-1607 目前已与 CDE 进行 NDA 前的沟通交流。

图表 6：阿尔茨海默病检测方法



资料来源：《阿尔茨海默病源性轻度认知障碍诊疗中国专家共识 2024》，华源证券研究所

2. 行业观点：坚持创新+出海+老龄化主线，关注国内政策修复

本周（6.9–6.13）、年初至今医药指数涨跌幅分别为+1.40%和+9.32%，相对沪深 300 指数的超额收益分别为 1.66%和 11.12%。

个股情况:本周上涨个股数量 218 家, 下跌个股 263 家, 涨幅居前为易明医药 (+38.49%)、赛升药业 (+36.35%)、澳洋健康 (+35.01%)、昂利康 (+34.30%)、康惠制药 (+30.93%)，跌幅居前为人民同泰 (-16.67%)、康乐卫士 (-12.33%)、万邦德 (-12.17%)、万泰生物 (-10.20%)、ST 中珠 (-9.34%)。

图表 7：本周申万医药行业涨幅 Top10

排序	代码	名称	市值 (亿元)	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	002826.SZ	易明医药	42.8	38.49%	84.32%	116.70%
2	300485.SZ	赛升药业	65.9	36.35%	30.01%	95.29%
3	002172.SZ	澳洋健康	39.0	35.01%	35.01%	62.62%
4	002940.SZ	昂利康	53.2	34.30%	74.97%	99.92%
5	603139.SH	康惠制药	26.2	30.93%	28.75%	82.45%
6	301015.SZ	百洋医药	128.0	28.89%	36.09%	4.96%
7	688656.SH	浩欧博	79.8	28.04%	32.00%	32.91%
8	300149.SZ	睿智医药	61.8	27.81%	20.84%	93.30%
9	300204.SZ	舒泰神	176.4	26.82%	39.36%	398.38%
10	002365.SZ	永安药业	74.4	26.38%	26.57%	216.02%
11	801150.SI	医药生物(申万)		1.40%	2.55%	9.32%
12	000300.SH	沪深 300		-0.25%	0.62%	-1.80%

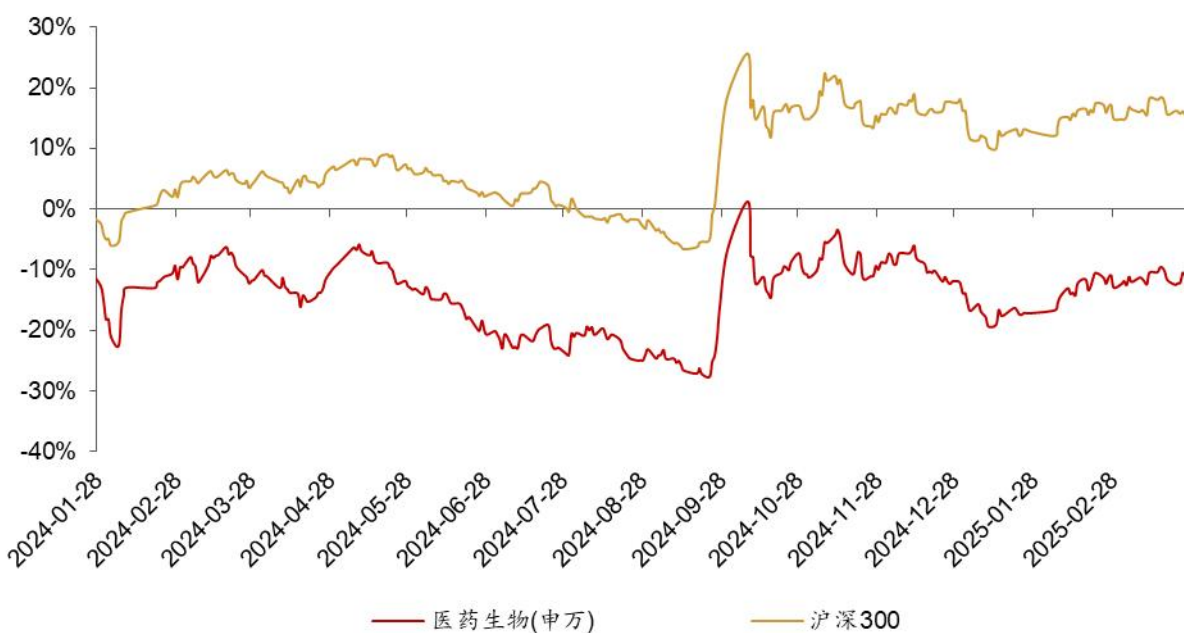
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 8：本周申万医药行业跌幅 Top10

排序	代码	名称	市值 (亿元)	本周表现	本月至今表现	年初至今表现
1	600829.SH	人民同泰	42.6	-16.67%	-7.78%	-2.00%
2	833575.BJ	康乐卫士	44.5	-12.33%	-12.04%	-4.11%
3	002082.SZ	万邦德	44.6	-12.17%	16.45%	13.37%
4	603392.SH	万泰生物	823.5	-10.20%	-6.08%	-7.62%
5	600568.SH	ST 中珠	32.9	-9.34%	3.77%	26.92%
6	000953.SZ	河化股份	25.6	-9.23%	-15.29%	24.87%
7	688163.SH	赛伦生物	21.6	-9.23%	9.31%	14.91%
8	002693.SZ	*ST 双成	31.0	-9.00%	-11.48%	-59.19%
9	301277.SZ	新天地	60.8	-8.87%	-1.90%	60.85%
10	688319.SH	欧林生物	66.2	-8.37%	-10.53%	53.87%
11	801150.SI	医药生物(申万)		1.40%	2.55%	9.32%
12	000300.SH	沪深 300		-0.25%	0.62%	-1.80%

资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 9：2024 年初至今医药指数表现



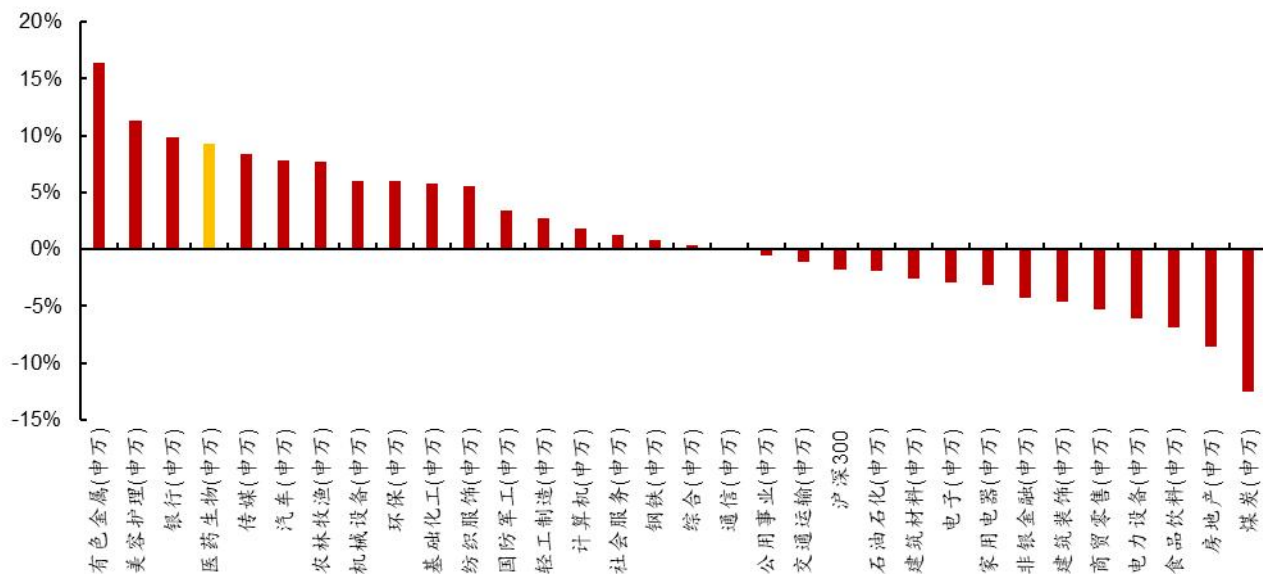
资料来源：Wind，华源证券研究所

细分赛道涨跌幅情况：

本周，化学制剂（+4.0%）、医疗服务 II（+2.4%）、医药生物（+1.4%）、化学原料药（+0.9%）、生物制品 II（+0.3%）、中药 II（-0.3%）、医疗器械 II（-0.5%）、医药商业 II（-0.8%）。

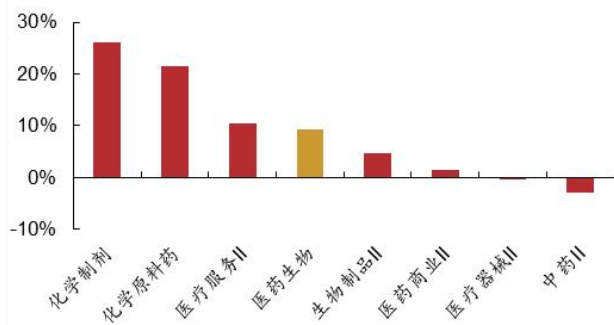
年初以来，化学制剂（+26.2%）、化学原料药（+21.5%）、医疗服务Ⅱ（+10.5%）、医药生物（+9.3%）、生物制品Ⅱ（+4.7%）、医药商业Ⅱ（+1.5%）、医疗器械Ⅱ（-0.4%）和中药Ⅱ（-3.0%）。

图表 10：申万各板块年初至今涨跌幅情况



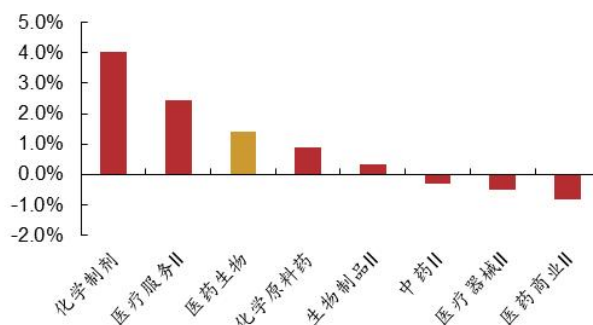
资料来源：Wind，华源证券研究所

图表 11：年初至今医药子板块涨跌幅情况



资料来源：Wind，华源证券研究所

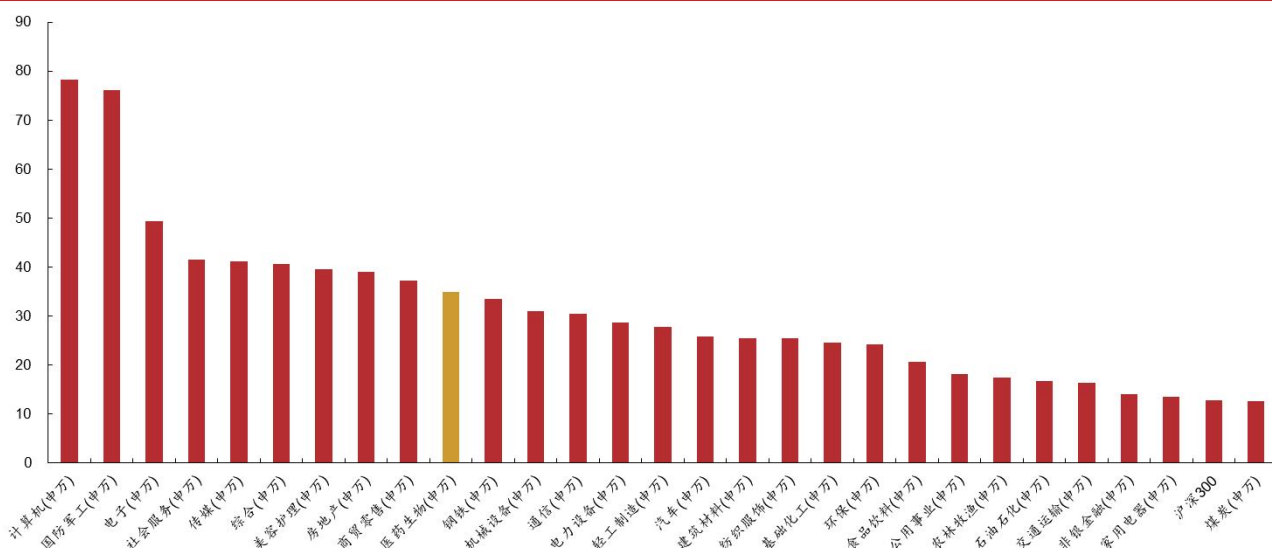
图表 12：本周医药子板块表现情况



资料来源：Wind，华源证券研究所

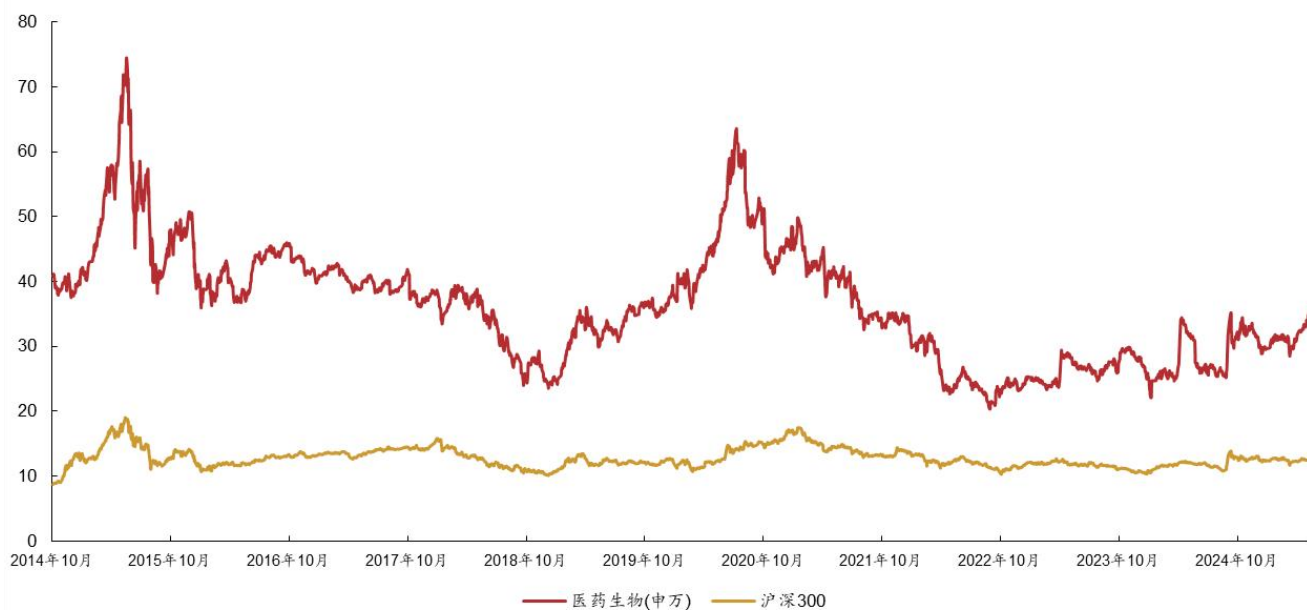
板块估值：截至 2025 年 6 月 13 日，申万医药板块整体 PE 估值为 34.9X，在申万一级分类中排第 10，从 PE 绝对值来看，目前医药估值仍在历史相对较低位置。各细分板块估值情况，目前化学制剂、生物制品和化学原料药等板块估值相对较高，医药商业和中药估值相对较低。

图表 13: 申万各板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 6 月 13 日, 整体 TTM 法)



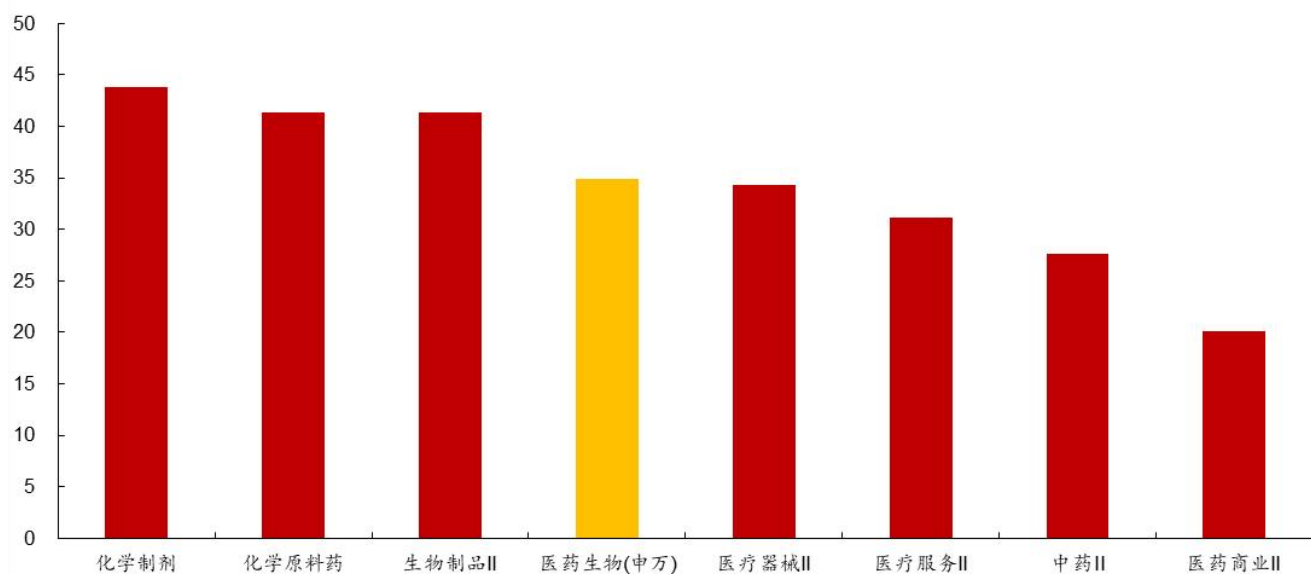
资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 14: 申万医药及沪深 300 PE 估值情况 (截至 2025 年 6 月 13 日, 整体 TTM 法)



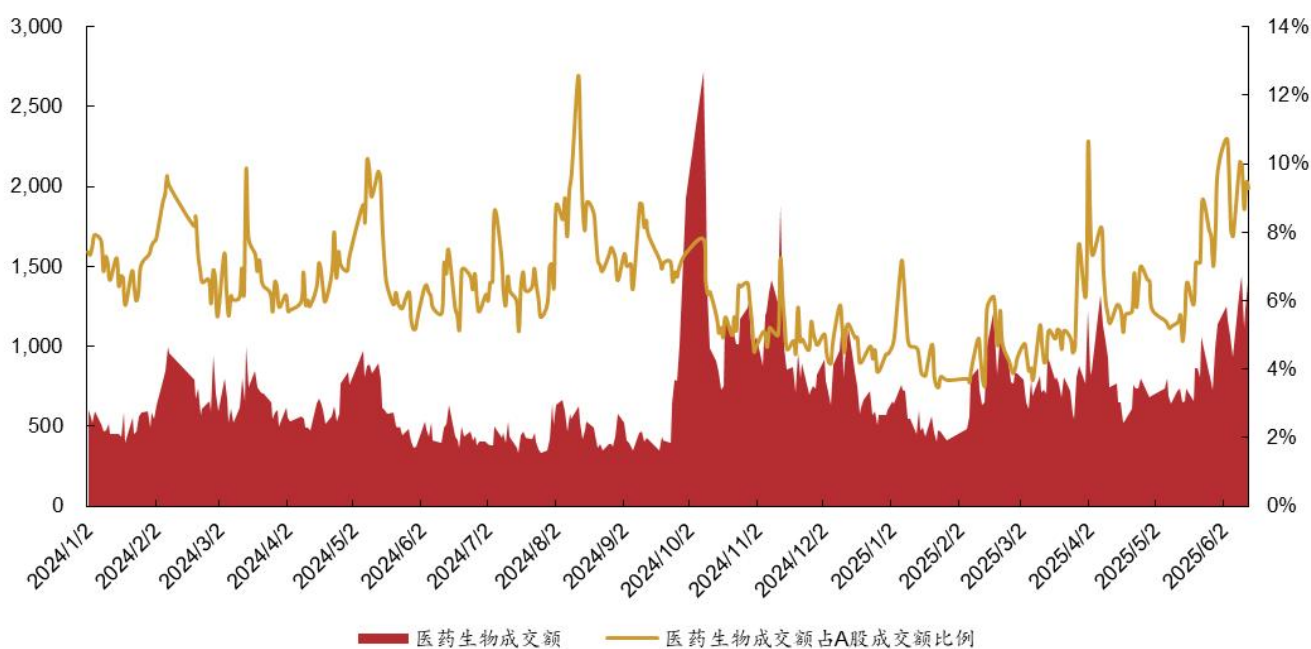
资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 15: 申万医药各细分板块 PE 估值情况 (截至 2025 年 6 月 13 日, 整体 TTM 法)



资料来源: Wind, 华源证券研究所

图表 16: 2024 年初至今医药成交额及占 A 股比例 (万亿)



资料来源: Wind, 华源证券研究所

投资观点: 2024 年医药指数下跌超 14%, 我们认为核心原因是新一轮医改进入深水区、政策扰动加速、企业成长动能转换带来阵痛所致, 其中行业整顿持续进行, 院内 DRG/DIP 进一步推广, 院外医保品种政策调整, 以及集采持续扩面等。当前位置, 我们认为医药已经呈现多重底, 医改影响或逐步调整到位, 板块估值、持仓均处于近年来低位, 业绩也有望迎来企稳回升。具体来看, 目前医药板块整体 PE 估值处于历史较低位置。展望 2025 年, 我们认为医药具备多方面的积极发展因素, 1) 创新产业已经初具规模, 多家公司的创新布局迎来收

获，传统 pharma 也已经完成创新的华丽转身；2）出海能力持续提升，创新药械的 license out 频频出现，中国企业已成为全球 MNC 非常重视的创新转换来源；3）老龄化持续加速，银发经济长坡厚雪；4）支付端看，医保收支仍在稳健增长，同时医保局积极推动商业保险的发展，构建多层次支付体系；5）AI 浪潮下，医药有望迎来新发展机遇，释放新的增长潜力。

整体来看，我们认为当前医改影响或逐步调整到位，行业有望边际好转，看好 2025 年医药否极泰来，结构性高增长的细分领域和个股值得期待。当前位置适合战略性布局，坚持“创新+出海+老龄化”主线，重点布局低估资产，建议关注以下方向：

1) 创新药械及产业链：国务院明确表态支持创新药全产业链发展，多地陆续出台相关政策，我们认为创新药/械及产业是较为明确的产业趋势，建议关注恒瑞医药、科伦药业、信立泰、科伦博泰、康方生物、和黄医药、翰森制药、中国生物制药、三生制药、信达生物、泽璟制药、热景生物、科兴制药、广生堂、赛诺医疗等。产业链方面，建议关注药明康德、药明生物、药明合联、凯莱英、泰格医药、百普赛斯、毕得医药等。

2) 出海：欧美占据全球医药主要市场份额，市场空间大，新兴市场正在快速发展，海外潜在增量十分可观，建议关注迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、鱼跃医疗、三诺生物、美好医疗、海泰新光、科兴制药等。

3) 国产替代：国产替代依旧是未来几年较为确定的产业趋势，其中内窥镜、微电生理等市场空间大、竞争格局好、国产率低，主要建议关注开立医疗、澳华内镜、惠泰医疗、微电生理等。

4) 老龄化及院外消费：随着 50 岁以上的老年化群体持续扩大，相关的健康消费需求有望稳步增长，建议关注昆药集团、鱼跃医疗、可孚医疗、华润三九、同仁堂、马应龙、羚锐制药、盘龙药业等。

5) 高壁垒行业：麻药和血制品行业需求较为稳健，供给端相对稳定，建议关注麻药（人福医药、恩华药业、国药股份等）、血制品（派林生物、天坛生物、博雅生物等）。

6) 小而美标的：随着市场情绪显著好转，部分前期估值受到压制、但业绩稳健或高增长公司有望迎来估值修复，建议关注百洋医药、普门科技、盘龙药业、方盛制药、立方制药、麦澜德等。

7) AI 主线或有望贯穿 2025 年，医药相关板块和个股有望反复表现，建议关注制药（晶泰控股、泓博医药）、大数据模型（润达医疗、美年健康、金域医学、医脉通、阿里健康、华大基因）、医疗设备（鱼跃医疗、三诺生物、联影医疗、开立医疗、华大智造）等。

本周建议关注组合：信立泰、华纳药厂、热景生物、三生制药、昆药集团；

六月建议关注组合：信立泰、科伦药业、中国生物制药、华纳药厂、科兴制药、热景生物、昆药集团、马应龙、开立医疗。

3. 风险提示

1) 行业竞争加剧风险：随着我国医药产业的不断创新与进步，不排除持续有新进竞争者加入从而造成竞争加剧的风险；

2) 政策变化风险：分级诊疗、医保支付改革持续成为医改重心，医保控费大趋势、带量采购等让医药产业中下游的收入利润有承压风险；

3) 行业需求不及预期风险：若终端需求不及预期，将会对公司业绩产生负面影响。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在 20% 以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在 5% ~ 20% 之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在 -5% ~ +5% 之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于 -5% 及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普 500 指数或者纳斯达克指数。